

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 (SF-36 / RAND-36)

Eje IV: Calidad de Vida Relacionada con la Salud • Estándar Oro Multidimensional Físico y Mental

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Salud SF-36 (Versión 1.0 / 2.0 en español).
Nombre Original	Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (Ware & Sherbourne, 1992).
Autores Originales	John E. Ware Jr., Ph.D. y Cathy Donald Sherbourne, Ph.D. (RAND Corporation / MOS).
Adaptación Hispana	Jordi Alonso, Montserrat Prieto y Josep M. Antó (1995, 1998); IMIM Barcelona, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). Perfil físico y mental multidimensional.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme genérico con 36 reactivos politómicos graduados.
Formato de Respuesta	Escalas Likert de formato variable (2 a 6 opciones de respuesta con anclajes verbales).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (≥ 14 años) en población general, clínica o ensayos farmacológicos.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos de cumplimentación autónoma o guiada.
Régimen de Licencia	Versión RAND-36 de dominio público / Derechos comerciales de QualityMetric (SF-36v2).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO INTEGRAL DE SALUD DEL MOS

El **SF-36** fue concebido en el marco del **Medical Outcomes Study (MOS)** con el propósito de ofrecer un instrumento de evaluación de resultados en salud exhaustivo, estandarizado y sensible:

- Definición Holística de la Salud (OMS):** Entiende la salud no meramente como ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social.
- Estructura Ortogonal Jerárquica:** Articula 8 dimensiones específicas que convergen en dos macro-componentes de segundo orden de base factorial: el **Componente Sumario Físico (CSF / PCS)** y el **Componente Sumario Mental (CSM / MCS)**.
- Universalidad y Comparabilidad Transnosológica:** Al ser genérico, permite contrastar el impacto en calidad de vida de enfermedades médicas crónicas (diabetes, artritis) frente a trastornos psiquiátricos mayores (depresión, esquizofrenia).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL (8 ESCALAS / 36 ÍTEMS)

Escala / Dimensión	Nº Ítems	Definición Operativa del Constructo en el SF-36
1. Función Física (FF)	10 ítems	Limitaciones para esfuerzo vigoroso, moderado, caminar, subir escaleras, inclinarse y aseo.
2. Rol Físico (RF)	4 ítems	Interferencia de los problemas de salud física en el rendimiento laboral y doméstico.
3. Dolor Corporal (DC)	2 ítems	Intensidad del dolor físico percibido y su grado de limitación en las tareas ordinarias.
4. Salud General (SG)	5 ítems	Percepción personal y global de la salud presente, resistencia a enfermar y futuro.
5. Vitalidad (VT)	4 ítems	Nivel subjetivo de energía, vigor y dinamismo frente a la sensación de cansancio y fatiga.
6. Función Social (FS)	2 ítems	Grado en que los problemas físicos o emocionales interfieren en las actividades sociales.
7. Rol Emocional (RE)	3 ítems	Limitaciones en el trabajo u ocupación derivadas de problemas de salud mental o afectivos.
8. Salud Mental (SM)	5 ítems	Presencia de disforia, angustia, sosiego afectivo y sensación de felicidad.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española de Alonso et al. (1995, 1998; $N = 9.163$ participantes en encuesta nacional de salud) acredita estándares de referencia mundial:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.78 - 0.93	Alfa superior a 0.85 en 7 de las 8 escalas; excelente homogeneidad factorial.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.81 - 0.89	Alta reproducibilidad temporal a 2 y 4 semanas en pacientes crónicos estables.
Validez de Constructo	CFI = 0.96; SRMR = 0.04	Confirmación empírica del modelo bidimensional de segundo orden (físico y mental).
Sensibilidad al Cambio	Tamaño efecto $d = 0.60 - 1.10$	Extraordinaria respuesta a tratamientos médicos, quirúrgicos y de psicoterapia.
Efectos Techo y Suelo	Suelo < 5%; Techo < 15%	Distribución adecuada excepto en Rol Físico/Emocional en poblaciones muy sanas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y PUNTUACIONES COMPONENTES

• **Recodificación de Ítems:** Invertir reactivos directos/negativos según clave técnica para que mayor puntuación siempre indique mejor salud. • **Transformación de las 8 Escalas a Métrica 0-100:** Cada dimensión se recalcula de acuerdo a la fórmula estándar:

$$\text{Puntuación Transformada (0 a 100)} = \left(\frac{\text{Puntuación Directa Observada} - \text{Mínimo Posible}}{\text{Rango Posible}} \right) \times 100$$

• **Componentes Sumarios Estandarizados (CSF y CSM):** Se calculan mediante puntuaciones z ponderadas por análisis factorial y se normalizan a escala T :

$$\text{Componente Sumario (CSF / CSM)} = 50 + 10 \times \sum (\text{Coeficiente Factorial}_j \times z_j)$$

• **Direccionalidad:** 0 = Peor estado de salud concebible; 100 = Estado de salud perfecto / plenamente funcional.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntos 0-100	T-Score (CSF/ CSM)	Significación Clínica y Estado Funcional
Excelente / Óptimo	80 a 100 pts	> 55 T	Salud excelente, vitalidad plena y ausencia de limitaciones de rol.
Normativo Poblacional	60 a 79 pts	45 a 55 T	Rango medio de la población española de referencia (Alonso et al.).
Deterioro Moderado	40 a 59 pts	35 a 44 T	Compromiso funcional perceptible; alertas en roles laborales y vitalidad.
Deterioro Severo	< 40 pts	< 35 T	Colapso de calidad de vida; disfunción clínica grave e invalidante.

PUNTO DE CORTE DE COMPROMISO CLÍNICO (T-SCORE < 40 / 1 DESVIACIÓN TÍPICA):

Una puntuación por debajo de **40 T** en el Componente Sumario Mental (CSM) define un riesgo elevado de trastorno afectivo mayor o de ansiedad tributario de derivación a salud mental. En el Componente Físico (CSF), puntuaciones < 40T indican patología médica limitante crónica con impacto invalidante.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN BIOMÉDICA Y PSICOSOCIAL CON SF-36

PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN CLÍNICA DEL SF-36:

- **Paso 1 (Línea Base en Atención Médica o Salud Mental):** Obtener el perfil gráfico de las 8 dimensiones y los sumarios CSF y CSM.
- **Paso 2 (Diferenciación de Patrones):** - *Perfil Físico Primario* (CSF < 35, CSM normal): Priorizar rehabilitación kinesiológica, analgesia multimodal y adaptaciones ergonómicas. - *Perfil Mental Primario* (CSM < 35, CSF normal): Priorizar abordaje psiquiátrico y psicoterapia cognitivo-conductual. - *Perfil Mixto Crónico* (ambos < 40): Patologías comórbidas complejas (fibromialgia, cáncer con depresión reactiva); requiere enfoque multidisciplinar.
- **Paso 3 (Monitorización de la Eficacia a los 3-6 Meses):** Una ganancia de ≥ 5 puntos en cualquier dimensión representa un Cambio Mínimo Clínicamente Importante (MCID).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN FIBROMIALGIA Y DEPRESIÓN

Identificación: Mujer de 46 años, profesora de secundaria, con diagnóstico de Fibromialgia y Episodio Depresivo Mayor comórbido de 2 años de evolución, en situación de incapacidad temporal reiterada. **Perfil Inicial SF-36 (0 a 100 puntos):** • *Dimensiones Físicas:* Función Física = 40; Rol Físico = 0; Dolor Corporal = 22; Salud General = 32. **CSF = 31.2 T (Deterioro Severo).** • *Dimensiones Mentales:* Vitalidad = 15; Función Social = 25; Rol Emocional = 0; Salud Mental = 28. **CSM = 27.5 T (Deterioro Severo).** **Tratamiento Integrado:** Se instauró Duloxetina 60 mg/día combinada con Pregabalina para control del dolor neuropático y disforia, junto con Terapia Cognitivo-Conductual para el dolor crónico (manejo del catastrofismo y ritmo de actividad gradual) y ejercicio aeróbico acuático supervisado. **Reevaluación a los 6 Meses:** • *Perfil Evolutivo:* FF = 70; RF = 50; DC = 58; SG = 52 (**CSF = 44.8 T**). VT = 50; FS = 62; RE = 66; SM = 64 (**CSM = 46.1 T**). Ambos componentes normalizados en el rango comunitario, logrando reincorporación docente con adaptación horaria.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DISOCIACIÓN EN DOLOR CRÓNICO:

Un CSM extremadamente bajo ($< 25T$) en pacientes con dolor físico desproporcionado debe alertar de riesgo autolítico grave encubierto bajo quejas somáticas.

EFFECTO SUELO EN ROLES:

En la versión 1.0, las escalas dicotómicas de RF y RE sufren efecto suelo en patología severa; una puntuación 0 no significa invalidez biológica irreversible.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Ware, J. E., Jr., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. *Medical Care*, 30(6), 473-483.
2. Alonso, J., Prieto, L., & Antó, J. M. (1995). La versión española del SF-36 Health Survey: Un instrumento para la medida de los resultados de salud. *Medicina Clínica*, 104(20), 771-776.
3. Alonso, J., Regidor, E., Barrio, G., et al. (1998). Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de Salud SF-36. *Medicina Clínica*, 111(11), 410-416.
4. Vilagut, G., Valderas, J. M., Ferrer, M., et al. (2005). Interpretación de los cuestionarios de salud SF-36 y SF-12 en España: Componentes físico y mental. *Medicina Clínica*, 124(6), 207-212.